



Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca — Cardiologie

Doc ID: RO-RC-2024-00892 | Date: 18.09.2024

REZUMAT CLINIC

SYNTHETIC — RESEARCH USE ONLY

DATELE PACIENTULUI

Pacient	Popescu, Ion	Data nașterii	17.06.1962 (62 ani)
Adresă	Str. Mihai Eminescu Nr. 34, Bl. 7, Ap. 12, 400001 Cluj-Napoca	CNP	1620617123456
Nr. fișă medicală	SCJU-CJ-2024-184302	Medic curant	Dr. Andreea Constantin, Medic Cardiolog Primar
Data internării	15.09.2024 Externare: 18.09.2024	Asigurare	CNAS — Nr. poliță: RO-2024-CJ-009834

1 — DIAGNOSTIC PRINCIPAL ȘI DIAGNOSTICE SECUNDARE

Diagnostic principal : Boală coronariană cronică — angina pectorală instabilă (I20.0)
Diagnostice secundare : Insuficiență cardiacă congestivă clasa NYHA II (I50.0), Hipertensiune arterială esențială, grad II (I10), Dislipidemie mixtă (E78.2), Diabet zaharat tip 2 (E11.9)

2 — ANAMNEZA ȘI MOTIVUL INTERNĂRII

Pacientul Ion Popescu, 62 ani, se prezintă la camera de gardă acuzând durere toracică anterioară cu iradiere în brațul stâng, apărută în repaus, cu durată de aproximativ 25 minute, asociată cu transpirații reci și dispnee ușoară. Antecedente: infarct miocardic anterior (2018, tratat prin angioplastie + stent LAD), HTA diagnosticată în 2010, DZ tip 2 diagnosticat în 2014, dislipidemie. Fumător până în 2019 (25 pachete-ani). Medicație curentă: Aspirină 100 mg/zi, Bisoprolol 5 mg/zi, Ramipril 10 mg/zi, Atorvastatină 40 mg/zi, Clopidogrel 75 mg/zi, Metformin 1000 mg × 2/zi.

3 — INVESTIGAȚII PARACLINICE

Parametru	Internare	Externare	Valori normale
Tensiune arterială	165/95 mmHg	134/82 mmHg	< 130/80 mmHg
AV / EKG	88/min, supra ST V2-V4	74/min, normal	60-100/min
Troponina I (hs)	0,42 ng/mL	0,18 ng/mL	< 0,04 ng/mL
BNP	387 pg/mL	210 pg/mL	< 100 pg/mL
Creatinină	104 μmol/L	98 μmol/L	62-106 μmol/L
Glicemie à jeun	8,7 mmol/L	6,9 mmol/L	3,9-5,6 mmol/L
HbA1c	7,8 %	—	< 6,5 %
Colesterol total	5,4 mmol/L	—	< 5,0 mmol/L

Ecocardiografie: FE 48 % (ușor redusă), hipokinezie perete anterior, regurgitare mitrală ușoară, presiune sistolică pulmonară estimată 34 mmHg. Coronarografie: Stenoza LAD proximală 60 % (stentul din 2018 permeabil), RCA neobstructivă. Rx torace: Discret desen vascular accentuat bilateral.

4 — TRATAMENT ȘI RECOMANDĂRI LA EXTERNARE

Tratament inițiat : Anticoagulare cu Heparină nefracționată 48 h, ISDN spray SL la nevoie, Furosemid 40 mg IV × 2/zi primele 24 h, optimizare antihipertensivă.
Modificări medicație : Bisoprolol crescut la 7,5 mg/zi; adăugat Eplerenona 25 mg/zi; Atorvastatină crescut la 80 mg/zi.

Urmărire :

Cardiologie în 2 săptămâni; reevaluare coronarografie în 3 luni; consultații: diabetolog, nutriționist; program recuperare cardiacă.

⚠ SYNTHETIC DOCUMENT — All patient data, names, identification numbers and clinical details in this document are entirely fictional and have been generated for AI research purposes. Any resemblance to real persons is purely coincidental. Not for clinical use.